



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : ايمان عباس عباس حسنين
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : حلوان
رقم البطاقة : 28109151701423 رقم التليفون : 01153377496
العنوان : مساكن السكه الحديد
العمر (تاريخ الميلاد) : 15-09-1981 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 30-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ايمان عباس عباس حسني National ID: 28109151701423	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

٢٠٢٦/٠٣ ٢٨١.٩١٥١٧.١٤٢٣
 حصله على دبلوم صناعة
 أنثى مقيمة متزوجة
 محمود عبدالمعصود عبدالستار ابراهيم
 البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٣/٠٩ ١



جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحقيق الشخصية
 ايمان عباس عباس حسنين
 ٢ ش عبود - ش ترعة البوصة الجزيرة
 مركز بنى سويف - بنى سويف
 ١٩٨١/٠٩/١٩ ٢٨١.٩١٥١٧.١٤٢٣
 LQ8887880





جهة الإصدار: فرع بنى سويف

تاريخ الإصدار: 2022-12-25

الى من يهمه الأمر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال فريق منظمة للاحتفاع الخاضعين لقانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 العمل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة
والمعاشات والارامل" وكذلك قانون 89 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم
86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن الممتدة " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص
بالمرأة المعيلة .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمين الصحي

والبحت تبين ان

المسيد (5) ايمان عباس بطاقة رقم 28109157701423

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد ان التأمين
يعتبر من القنات. غير المتكفلة بالتأمين الاجتماعي
ومعها

تاريخ الطابع: 2022-12-25

الموظف المختار

جمال ابو بكر



مستمل 279495

يعتبر هذا الخطاب ساري لمدة شهر من تاريخ الاصدار

الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار

Name: إيمان عباس عباس		
MR. : 4917		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient underwent neoadjuvant chemotherapy in 2022 followed by left-sided total mastectomy with sentinel lymph node biopsy, pathologically staged as T0N0. Multidisciplinary team discussion in December 2022 recommended adjuvant therapy with tamoxifen and placement of a port. As of December 2025, the surgical margins are free and the patient remains disease-free. In March 2026 the patient, a 44-year-old individual with a left breast invasive ductal carcinoma, was staged clinically as T2 N0 M0, grade II-ER positive, HER2-negative. The treatment plan included neoadjuvant chemotherapy consisting of three cycles of FEC and three cycles of Taxotere, followed by left mastectomy and sentinel node evaluation. Post-operative management comprised tamoxifen and zoladex initiated in December 2022; however, the clinician expressed uncertainty regarding the four-year duration of zoladex and recommended discontinuation of zoladex while continuing tamoxifen alone. The patient's surgical margins and clinical status remain free of disease. The patient has completed three cycles of neoadjuvant chemotherapy with FEC and three cycles of Taxotere.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 19-09-2026
	الطبيب المعالج : نهى سعيد علي محمد	
يعتمد ,		

Patient Name: Eman Abbas Abbas Hasanain	Date : 22/10/2022
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 40 Year(s)
Medical ID: 1927/2022	Pat. ID: 11760

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Left BC, on neoadjuvant chemotherapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO views DBT (Digital Breast Tomosynthesis).
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- The breasts are heterogeneously dense which may obscure small lesions (ACR C)
- Left upper central spiculated lesion harboring suspicious microcalcifications, with anterior group of microcalcifications, measuring collectively 4.3x2.5 cm, seen 2.1 cm from the nipple. US showed spiculated hypoechoic solid mass with internal echogenic shadowing tail. The anterior heterogeneous parenchyma, is not seen in today study
- No right suspicious mass lesions, suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- Complementary ultrasound showed no right solid or cystic mass lesions.
- Bilateral Retroareolar prominent ducts with internal clear contents
- Normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Bilateral non-specific axillary LNs.

Opinion:

- Left upper central pathologically proved malignant mass with malignant microcalcifications (partial response) (BIRADS6)
- Normal right breast study (BIRADS 1)

Yours truly

Signature Dr. Yasmin Nada

22/10/2022 10:54 AM



Patient Name : الأستاذة / ايمان عباس حسان	Request No. : 13009439
Patient No. : 28109151701423	Request Date : 17/11/2022
Path No. : 3500/22	Verification Date : 28/11/2022
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 41 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer post NACT

Nature of the specimen: Left simple mastectomy & Left SLNB

Gross Examination:

- Procedure: Left SM specimen measured 17x14x5 cm with covering skin ellipse measured 14x10cm
- Tumor extent : An ill defined rubbery tumour deep site
- Size: 12x9x3 cm
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly
- Distance from margins: 3cm away from deep margin, 1.5 cm away from the skin.
- Lymph nodes number and size: 5 SLNs up to 1x1 cm

Microscopic examination:

- Near complete pathological response, Tumor necrosis index 97%. (<3mm residual component) with fibroadenosis and sclerosing adenosis.
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Free L.Ns (0/5)
- Resection Margins: Free margins
- Histologic response to therapy: Near complete pathological response

Diagnosis:

Left simple mastectomy & Left SLN biopsy (post NACT):

- Near complete pathological response (<3mm residual component)
- Free resection margins
- Free nipple and areola
- Free SLNs (0/5)
- Stage : ypT1a . ypN0 .

Verified by :

Dr.Marwa mahmoud

Printing Date : 03/12/2022 13:07:11

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

مركز الباثولوجي - معمل الباثولوجي - مستشفى عين شمس - القاهرة - مصر
Room No. 401 - First Floor Building No. 401 - Eye Center - Ain Shams University - Cairo, Egypt

Patient Name: Eman Abbas Abbas Hasanain	Date : 09/11/2023
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 41 Year(s)
Medical ID: 1927/2022	Pat. ID: 11760

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had left MRM in

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- The right breast is heterogeneously dense which may obscure small lesions (ACR C).
- No spiculated masses or grouped microcalcifications
- Complementary ultrasound also showed no right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hilum and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No right breast suspicious findings (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Engy Abdallah
09/11/2023 1:29 PM



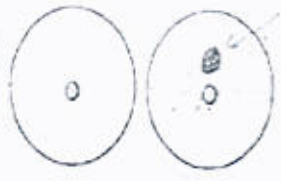
GA

MDT FORM

15/6/2022

Name	أحمد محمد علي	MRN	1957/15
Age	65	ID	581.91011/1558
Menopausal status	Post	Phone	110 2257297
OCP		Marital status	
Co morbidity		Family history	

Clinical Data

Bx:	IDC 9II				 T ₁ N ₀ M ₀			
ER:	8/8	PR:	8/8	HER2:		-ve	Ki67:	10%
Sonomammography: Breast Multiplex upper midline masses BIRADS 6								
Mets Workup: CT (CP → Abdomen)								
Recommendations: DBac scan Otho Lab								

MDT OUTCOME & PLAN

In view of multiple retro-areolar satellites & microcalcifications
→ pt will be for skin sparing mastectomy.

For: NACT (DEC X3 → to be X3) + axilla
He for Ct. SSIT & SLNB +/- reconstruction.

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

C.C. 17/10

C.C. 17/10